

Semiologia: anamnese, sintomas e arritmias

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 47 (PDF p. 537–550 e 556–560)

EM 30 SEGUNDOS

- **Dor anginosa:** retroesternal, **constritiva** (mão fechada no peito), irradia para mandíbula, MMSS, epigástrio e dorso; vem com **esforço**, emoção, frio ou refeição; alivia com **repouso** e **nitrato em 3–4 min.**
- **Duração da dor:** angina **2–3 min** (raro > 10); angina instável até **20 min**; infarto > **20 min**, começa em repouso, com sudorese, náuseas e vômitos.
- **Pericardite:** dor contínua por horas, piora com **respiração e decúbito dorsal**, melhora ao **incliná-lo para frente**. **Dissecção aórtica:** súbita, **lancinante**, irradia para o **dorso (interescapular)**.
- **Dispneia da IVE:** de esforço (grandes → médios → pequenos, **progressão rápida**), **ortopneia**, **dispneia paroxística noturna** (asma cardíaca) e **edema agudo de pulmão** (expectoração **rósea e espumosa**). Causa básica: **congestão pulmonar**.
- **Palpitações:** “falhas” e “arrancos” = **extrassístoles**; início e fim **súbitos** = **taquicardia paroxística** (FC > 150); irregular e rápida = **fibrilação atrial**.
- **Síncope cardíaca:** bradicardia < **30–40** ou taquicardia > **150 bpm**. **Stokes-Adams** = síncope com convulsão por arritmia (Chagas com BAV). A **vasovagal** é a mais comum e melhora ao **deitar**.
- **Cianose:** Hb reduzida $\geq$ **5 g/dL** (anêmico grave não fica cianótico). **Central** (melhora com O₂) × **periférica** (pele fria, melhora ao aquecer ou elevar o membro).
- **Edema cardíaco (IVD):** começa nos **maléolos**, bilateral, **vespertino**, com **jugulares túrgidas** e **hepatomegalia**; generalizado = **anasarca**.
- **FA:** ritmo **completamente irregular**, B1 de intensidade variável (**delirium cordis**) e **déficit de pulso**. **BAVT:** FC **30–40**, regular, B1 variável com **bulha em canhão**.

1 Anamnese

Identificação e antecedentes já sugerem o diagnóstico:

- **Idade:** crianças e jovens têm **cardiopatias congênitas** e **febre reumática**; de 20 a 50 anos, **Chagas** e **hipertensão**; acima de 50, **doença coronariana**.
- **Sexo:** **estenose mitral** e **prolapso mitral** são mais comuns em **mulheres jovens**; a aterosclerose coronária predomina nos homens até os 45 anos.
- **Naturalidade e moradia:** habitação rural precária em área endêmica lembra **doença de Chagas**.
- **Antecedentes:** **amigdalite estreptocócica** (lesão valvar reumática), dieta rica em gordura (aterosclerose), doença renal (hipertensão).
- **Hábitos:** **tabagismo**, álcool e sedentarismo.

2 Dor torácica

Dor precordial **não** é sinônimo de dor cardíaca: pode vir da parede torácica, pleura, esôfago, estômago, aorta, mediastino ou ser psicogênica (Quadro 47.1 do Porto). Avalie **localização, irradiação,**

caráter, intensidade, duração, fatores desencadeantes e de alívio e sintomas associados. As quatro dores mais cobradas estão na **Tabela 1**.

Tabela 1 Dores torácicas de origem cardiovascular e psicogênica (Porto, cap. 47).

Tipo	Características
Isquêmica (angina)	Retroesternal, constritiva (“aperto”, “peso”, “queimação”; mão fechada no peito). Irradia para pescoço, mandíbula , ombros, membros superiores , epigástrio e região interescapular. Vem com esforço , emoção, frio, taquicardia ou refeição copiosa; alivia com repouso e nitrato sublingual em 3–4 min .
Infarto agudo	Mesmo caráter, porém > 20 min (até horas), começa em repouso , intensa, com sudorese fria, náuseas, vômitos , palidez e sensação de morte iminente.
Pericárdica	Retroesternal junto à borda esternal esquerda, irradia para pescoço e costas; contínua por horas; piora com respiração, tosse, deglutição e decúbito dorsal ; alivia ao inclinarmos o tórax para frente ou na posição genupeitoral.
Aórtica (dissecção)	Súbita , muito intensa, lancinante , retroesternal, irradia para pescoço, região interescapular e ombros; paciente inquieto. O aneurisma sem dissecção quase não dói.
Psicogênica	Na ponta do coração (perimamilar), surda , dura horas ou semanas, sem relação com esforço; vem com palpitações e dispneia suspirosa .

DURAÇÃO DA DOR ISQUÊMICA

Angina estável: 2–3 min, raramente > 10 min (só hipóxia). **Angina instável:** até 20 min. **Infarto:** > 20 min (necrose). Se o nitrato leva 5–10 min para aliviar, pense em angina instável.

Outras pistas: dor que piora à **palpação das articulações condroesternais** é a **síndrome de Tietze**; dor com mudanças de decúbito ou movimentos do pescoço vem da **coluna**; dor retroesternal ao **deglutir** vem do **esôfago**.

3 Palpitações

Palpitação é a **percepção incômoda dos batimentos** e nem sempre significa arritmia (exercício, emoção, anemia, hipertireoidismo, café, drogas). Pergunte frequência, ritmo, modo de **início e término** e uso de estimulantes.

- **“Falhas”, “arrancos”, “tremor”: extrassístoles.** O paciente sente mais o batimento **pós-extrassistólico**; o “coração parou” é a **pausa compensadora**.
- **Início e fim súbitos: taquicardia paroxística.** Início súbito e fim gradual: taquicardia sinusal ou ansiedade.
- **FC 100–150** sugere taquicardia **sinusal**; **> 150** sugere **paroxística**.
- **Rápidas e irregulares: fibrilação atrial.**
- **De esforço:** têm o mesmo valor da dispneia de esforço.

4 Dispneia

Na cardiopatia, dispneia significa **congestão pulmonar**: a pressão alta no átrio esquerdo passa às veias e capilares pulmonares, o líquido vai ao interstício e o pulmão fica mais rígido. Os tipos estão na **Tabela 2**.

Asma cardíaca × brônquica: a cardíaca surge **deitado** e melhora ao sentar, com taquicardia, **galope** e **estertores finos nas bases**; na brônquica a posição não alivia e os **sibilos** predominam. A radiografia mostra **congestão** na cardíaca e **hiperinsuflação** na brônquica.

Tabela 2 Tipos de dispneia na insuficiência ventricular esquerda (Porto, cap. 47).

Tipo	Características
De esforço	A mais comum. Aos grandes (subir escadas, andar depressa), médios (andar no plano, poucos degraus) e pequenos esforços (banho, vestir-se, falar). Na IVE progride rápido ; na doença pulmonar e na anemia, devagar.
De decúbito (ortopneia)	Surge logo ao deitar (mais sangue dos membros inferiores e do leito esplâncnico chega ao pulmão). O paciente usa vários travesseiros ou dorme sentado.
Paroxística noturna	O paciente acorda sufocado, com tosse seca, e precisa sentar ou levantar. Com sibilos por congestão da mucosa brônquica: asma cardíaca .
Edema agudo de pulmão	Forma grave: dispneia intensa, expectoração espumosa rósea , cianose, sibilos e estertores . Típico do infarto e da estenose mitral .
Cheyne-Stokes	Apneia (15–30 s, até 60 s) seguida de respirações que crescem e depois diminuem. Na IVE, hipertensão, coronariopatia e lesões neurológicas; pode ocorrer no sono de idosos e crianças.

5 Tosse, hemoptise e chiado

A **tosse da IVE** é **seca** e **noturna**, por congestão; no edema agudo vem com **expectoração rósea espumosa**. Aneurisma de aorta e átrio esquerdo grande causam tosse por compressão brônquica ou do nervo laríngeo recorrente. Lembre que os **inibidores da ECA** causam tosse seca.

Hemoptise é a eliminação de **mais de 2 mL** de sangue pelas vias aéreas (sangue vivo, arejado, com tosse). Na hematêmese o sangue é escuro, em “borra de café”, com restos alimentares. O aspecto ajuda:

- **Espumosa e rósea:** edema agudo de pulmão.
- **“Cor de tijolo”:** pneumonia pneumocócica.
- **“Geleia de framboesa”:** infarto pulmonar.
- **Volumosa, sangue vivo:** ruptura de veias brônquicas dilatadas, como na **estenose mitral**.

6 Síncope e lipotimia

Síncope é a perda súbita e transitória da consciência e do tônus postural; **lipotimia** (pré-síncope) é a perda parcial. A causa é a **queda transitória do fluxo cerebral**. A anamnese do episódio orienta a causa (**Tabela 3**).

Tabela 3 Dados da anamnese que sugerem a causa da síncope (Porto, Quadro 47.6).

Dado	Causa provável
Início súbito, sem pródromos	Arritmia cardíaca, causa neurológica
Pródromos (palidez, sudorese, náusea)	Vasovagal
Ao levantar-se	Hipotensão ortostática (anti-hipertensivos, diuréticos)
Muito tempo em pé, dor, emoção, sangue	Vasovagal
Ao virar a cabeça ou apertar o colarinho	Hipersensibilidade do seio carotídeo
Durante o exercício	Obstrução da via de saída do VE (estenose aórtica)
Exercício com os braços	Roubo da subclávia
Convulsão, mordedura da língua, incontinência; recuperação lenta	Causa neurológica

Causas cardíacas: arritmias com FC < 30–40 ou > 150 bpm, estenose aórtica, infarto, embolia pulmonar, mixoma atrial e trombose de prótese. A **síndrome de Stokes-Adams** é a síncope por **parada, bradi ou taquiarritmia grave**, com **convulsões**; é comum na **cardiopatia chagásica com BAV de 2º ou 3º grau**. A tontura surge 2–5 s após a arritmia, a perda da consciência em 10–15 s e as convulsões em 20–40 s.

Causas extracardíacas: a **vasovagal** (neurogênica) é a **mais comum**: vasodilatação com inibição simpática e aumento vagal, e **melhora rápida ao deitar**. Outras: **hipotensão postural**, seio carotídeo, síncope pós-tosse e pós-micção, hiperventilação e **hipoglicemia**.

7 Cianose

Cianose é a cor azulada da pele e mucosas quando a **hemoglobina reduzida** chega a **5 g/dL** nos capilares (normal $\approx$ 2,6). Por isso o **anêmico grave não fica cianótico**. Examine à luz do dia lábios, nariz, orelhas, língua e extremidades. Os tipos estão na **Tabela 4**.

Tabela 4 Tipos de cianose (Porto, cap. 47).

Tipo	Mecanismo e exemplos
Central	Sangue arterial mal oxigenado: altitude, doença pulmonar, shunt direita-esquerda (tetralogia de Fallot, Eisenmenger, transposição) . Generalizada, inclusive nas mucosas; melhora com O₂ .
Periférica	Perda exagerada de O ₂ nos capilares por estase ou vasoconstrição (frio, IC, choque, flebite). Áreas distais, pele fria ; melhora ao aquecer ou elevar o membro.
Mista	Central + periférica, como na IC congestiva grave .
Por alteração da Hb	Meta-hemoglobina (> 20% da Hb) por nitritos, anilinas, sulfas: cor azul-acinzentada.

Baqueteamento digital (dedos em baqueta de tambor, unhas em vidro de relógio) com cianose sugere **cardiopatia congênita cianótica** ou doença pulmonar crônica; sem cianose, lembre **endocardite infecciosa subaguda**. Cianose desde o nascimento sugere cardiopatia congênita.

8 Edema, astenia e cócoras

O **edema cardíaco** vem da **insuficiência ventricular direita**: a pressão venosa alta aumenta a pressão hidrostática nos capilares e o **sistema renina-angiotensina-aldosterona** retém sódio e água.

- Começa nos **maléolos**, sobe para pernas e coxas; é **bilateral** (assimetria sugere varizes ou trombose associada).
- É **vespertino**: piora ao longo do dia e melhora com o repouso noturno. No acamado, fica na região **sacral**.
- Deixa **fóvea** à compressão. Edema generalizado com serosas é a **anasarca**.
- Vem com **jugulares túrgidas**, **refluxo hepatojugular** e **hepatomegalia**. Na **pericardite constritiva** e na lesão tricúspide, a **ascite** predomina.
- O peso pode subir **até 10%** antes de surgir fóvea.

Astenia (fraqueza) é comum na IC e no infarto, por baixo débito; piora com diurético em excesso e **hipopotassemia** (cãibras). A **posição de cócoras** é adotada por crianças com **cardiopatia congênita cianótica** (tetralogia de Fallot): a compressão das femorais **eleva a resistência sistêmica**, reduz o shunt direita-esquerda e melhora a saturação.

9 Arritmias ao exame clínico

A arritmia é suspeitada pelos sintomas, pelo **pulso radial**, pelo **pulso venoso** e pela **ausculta**. $DC = VS \times FC$: abaixo de **40** ou acima de **160 bpm** a compensação falha e o DC cai. As taquiarritmias encurtam a diástole (**Fig. 1**); as bradiarritmias reduzem a frequência (**Fig. 2**). As duas podem causar síncope e **Stokes-Adams**; as causas mais frequentes são a **doença de Chagas** e a **cardiopatía isquêmica**. Os achados de cada arritmia estão na **Tabela 5**.

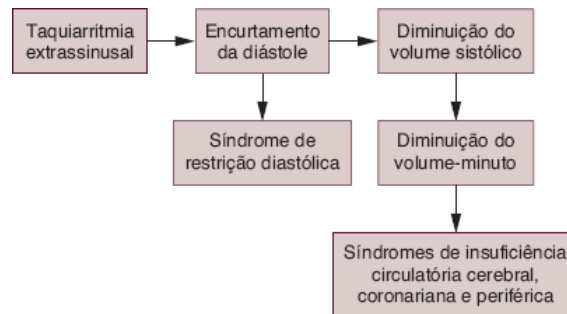


Fig. 1 Repercussões das taquiarritmias: diástole curta, menor volume sistólico, restrição diastólica e insuficiência circulatória cerebral, coronariana e periférica. (Porto, Fig. 47.6)

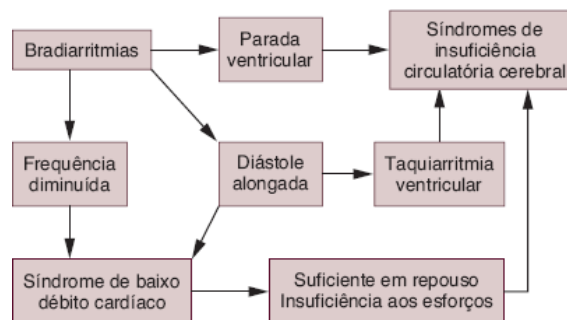


Fig. 2 Repercussões das bradiarritmias: frequência baixa, baixo débito (suficiente em repouso, insuficiente aos esforços) e insuficiência circulatória cerebral. (Porto, Fig. 47.7)

Tabela 5 Arritmias reconhecíveis ao exame clínico (Porto, cap. 47).

Arritmia	Achados
Taquicardia sinusal	FC > 100 (até 150 no adulto), por simpático; esforço, emoção, febre, anemia, hipertireoidismo, IC. B1 hiperfonética .
Bradicardia sinusal	FC < 60 (40–50), por vagal; atletas, sono, hipotireoidismo, hipertensão intracraniana, betabloqueador, digital. Aumenta com o exercício ; B1 hipofonética.
Arritmia sinusal	FC aumenta na inspiração e diminui na expiração; normal em crianças e jovens; some com exercício e apneia.
Extrassístoles	Batimento premature seguido de pausa compensadora . A ventricular não gera onda de pulso; o batimento seguinte é mais forte. Bigeminismo: 1 extra após cada normal.
Taquicardia paroxística	Foco ectópico a 150–250/min , início e fim súbitos . Supraventricular em geral > 180 bpm; ventricular é mais grave.
Fibrilação atrial	Átrios a 400–600/min , ventrículos irregulares: ritmo completamente irregular , B1 variável (delirium cordis), déficit de pulso . Causas: estenose mitral , Chagas, isquemia, hipertireoidismo.
BAV total (3º grau)	Átrios e ventrículos independentes, FC 30–40 , pulso amplo, lento e regular; B1 de intensidade variável com bulha em canhão ; não acelera com exercício.

A extrassístole ventricular isolada, o bigeminismo e a salva estão na **Fig. 3**: no batimento prematuro ouve-se só a B1 e falta a onda de pulso.

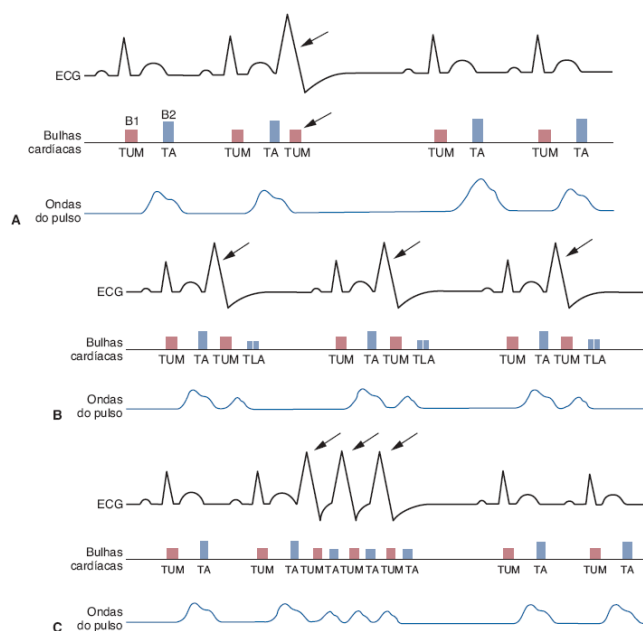


Fig. 3 A, extrassístole ventricular isolada com pausa compensadora; B, bigeminismo; C, extrassístoles em salva. Bulhas (TUM-TA) e ondas de pulso. (Porto, Fig. 47.8)

Na **fibrilação atrial** (**Fig. 4**) não há onda P e as bulhas e os pulsos variam em intervalo e intensidade.

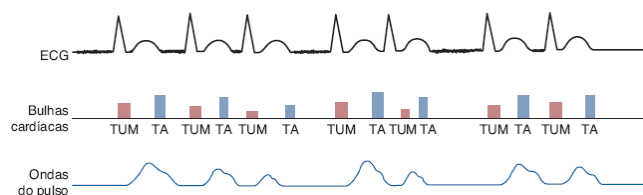


Fig. 4 Fibrilação atrial: sem onda P, bulhas e ondas de pulso irregulares em ritmo e amplitude. (Porto, Fig. 47.9)

No **BAV total** (**Fig. 5**) as ondas P não se relacionam com o QRS e, de vez em quando, surge a **bulha em canhão** (sístole atrial 0,10–0,12 s antes da ventricular, valvas bem abertas).

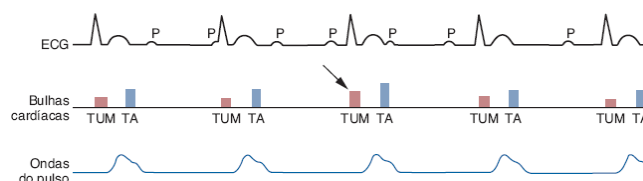


Fig. 5 Bloqueio atrioventricular total: ritmo lento e regular, B1 variável e bulha em canhão (seta). (Porto, Fig. 47.10)

BRADICARDIA SINUSAL × BAV TOTAL

Ambos têm pulso lento e regular. No **BAVT** a FC é < 40, a **B1 varia** (bulha em canhão) e a FC **não sobe** com exercício. Na **bradicardia sinusal** a FC costuma ser > 40, a B1 é constante e a FC **sobe** com exercício.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Angina estável	2–3 min	Raro > 10 min
Angina instável	Até 20 min	
Infarto agudo	> 20 min	Começa em repouso
Alívio da angina com nitrato	3–4 min	5–10 min: instável
Palpitação: taquicardia sinusal	FC 100–150	
Palpitação: taquicardia paroxística	FC > 150	Foco a 150–250/min
Apneia do Cheyne-Stokes	15–30 s	Até 60 s
Hemoptise	> 2 mL de sangue	
Síncope por arritmia	FC < 30–40 ou > 150	
Stokes-Adams: perda da consciência	10–15 s após a arritmia	Convulsão em 20–40 s
Hb reduzida para cianose	≥ 5 g/dL	Normal ≈ 2,6
Meta-hemoglobina com cianose	> 20% da Hb	
Peso retido antes da fôvea	Até 10%	
DC compensado	FC entre 40 e 160	
Fibrilação atrial (átrios)	400–600/min	
BAV total	FC 30–40	
Bulha em canhão	Sístole atrial 0,10–0,12 s antes	

PEGADINHAS DE PROVA

- Dor precordial **não** é sinônimo de dor cardíaca.
- Dor **perimamilar** ou na **ponta** quase nunca é cardíaca (psicogênica).
- Angina que dura **mais de 20 min** já não é angina estável.
- **Ortopneia** surge **logo ao deitar**; a **paroxística noturna** acorda o paciente depois de horas.
- **Anemia grave** impede a cianose (falta Hb reduzida).
- Cianose **periférica** tem pele **fria**; a **central** melhora com O₂.
- Na extrassístole o paciente sente o batimento **após** a pausa, não o prematuro.
- Síncope **ao esforço** sugere **estenose aórtica**.
- **Bradicardia sinusal** acelera com exercício; o **BAVT** não.
- **Inibidores da ECA** causam tosse seca.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Síndrome coronariana aguda.** Dor constritiva > **20 min**, em repouso, com sudorese e náuseas: pensar em **infarto** e fazer ECG imediato.
- **Pericardite aguda.** Dor que **melhora inclinando para frente** e piora deitado; ao exame, **atrito pericárdico**.
- **Dissecção de aorta.** Dor **lancinante** irradiada para o dorso, em hipertenso; pulsos e PA assimétricos.
- **Insuficiência cardíaca esquerda.** Dispneia progressiva, **ortopneia**, **DPN**, tosse noturna, **estertores** nas bases e **B3**.
- **Insuficiência cardíaca direita.** **Edema vespertino** de membros inferiores, **jugulares túrgidas**, **hepatomegalia** e ascite.
- **Doença de Chagas.** Natural de zona endêmica com **BAV**, extrassístoles, **Stokes-Adams** e IC.
- **Estenose mitral.** Mulher jovem com dispneia, **hemoptise**, **FA** e edema agudo de pulmão.
- **Tetralogia de Fallot.** Criança com **cianose central**, **baqueteamento** e **posição de cócoras**.

Glossário

Termo	Significado
Angina de peito	Dor por isquemia miocárdica transitória.
Síndrome de Tietze	Osteocondrite condroesternal dolorosa.
Palpitação	Percepção incômoda dos batimentos cardíacos.
Ortopneia	Dispneia ao deitar, aliviada sentado.
Dispneia paroxística noturna	Crise de dispneia que acorda o paciente.
Asma cardíaca	DPN com broncospasmo e sibilos.
Cheyne-Stokes	Respiração periódica com apneias.
Hemoptise	Eliminação de sangue das vias aéreas pela tosse.
Síncope	Perda súbita e transitória da consciência.
Lipotimia	Pré-síncope: perda parcial da consciência.
Stokes-Adams	Síncope com convulsão por arritmia grave.
Cianose	Cor azulada por Hb reduzida ≥ 5 g/dL.
Baqueteamento digital	Dedos em baqueta e unhas em vidro de relógio.
Anasarca	Edema generalizado com derrames cavitários.
Pausa compensadora	Pausa longa após a extrassístole.
Déficit de pulso	Menos pulsos radiais que batimentos cardíacos.
Delirium cordis	Irregularidade total da fibrilação atrial.
Bulha em canhão	B1 muito intensa no BAV total.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Porto	Cap. 47 · PDF p. 537–540	Anamnese e dor torácica (Quadro 47.1)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 540–545	Palpitações, dispneia, tosse, chiado e hemoptise (Quadros 47.2 a 47.5)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 545–548	Síncope e lipotimia (Quadro 47.6)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 548–550	Cianose, edema, astenia e posição de cócoras
Porto	Cap. 47 · PDF p. 556–560	Ritmo, frequência e arritmias (Quadro 47.7, Fig. 47.6 a 47.10)